

QUELQUES NOTIONS GENERALES

I. Motif de consultation

1. Douleur au niveau FID : suspicion **appendicite**.

Localisation +++ (examen clinique).

Rechercher : fièvre, vomissements, transit (diarrhée / constipation / conserver), dernier angine / covide .., prise un trt antérieure, parasitose.

Demander : échographie avec doppler, bilan complet.

Puis : scorer le malade +++.

2. Douleur abdominale + vomissements + transit non conservé + cri incessant = suspicion **occlusion intestinale** chez un nourissant (surtout ++) → interrogatoire + demander échographie avec doppler.

3. AVP / chute :

- ASP
- Echographie abdominale pelvienne.
- Contrôle après 48 h.
- Avis CCI ++.

4. Hernie : ombilicale / inguinale.

II. Lettre d'échographie

Cher confrère,

Permettez-moi de vous adresser l'enfant / nrs / nné sus nommé (e) sus âgé (e), sans ATCDs (si + ATCDs → citer + mentionner avec au sans trt). Qui présente (motif de consultation).

Je vous le confie pour une échographie (type : abdomino-pelvienne, inguino-scrotale ...) +/- doppler (pour une bonne visualisation de la vascularisation sanguine).

Cordialement, Confraternellement.

III. Autorisation de sortie

La garde malade : nom et prénom

Va sortir à (l'heure de sortie) et va remplacer par (nom et prénom de la personne qui la remplacer).

IV. Bilan complet

- FNS + groupage
- Glycémie
- Bilan rénal (urée/créat)
- Ionogramme sanguine (Na+/K+/Cl-)
- TP, TCK = bilan d'hémostase.
- CRP avec titrage

V. Remplir les dossiers

GRANDE ENVELOPPE :

- Dgc en haut + groupage
- Service CCI
- Nom, prénom, age, adresse.
- Entrée le : la date d'entrée
- Sortie le : la date de la sortie
- Numéro de téléphone :
- TP : temps patient = c'est l'heure d'arrivé – le temps de début des symptômes.
- HA : heure d'arrivé = c'est presque 30 mn à 1h, le temps qu'on a pris pour hospitaliser le

malade.

- TH : temps d'hospitalisation

CONTENU :

- Fiche de trt : vert ou blanc
- Fiche de dgc : orange
- Fiche de rendez-vous
- Echographie, TDM,
- Lettre d'orientation
- Bilans...

VI. Les tubes

→ Tube sec (rouge) :

- CRP
- TPHA : Treponema palladium : syphilis.
- ALAT (pour poser dgc d'une maladie hépatique spécifique : ↑ s'il y a une maladie)/ASAT (pour surveiller : foie + tube digestif)
- Ca²⁺
- HDL
- HIV
- Hbs
- HCV : hépatite C
- Rubéole
- Toxoplasmose
- Magnésémie
- Hépatite ABC
- Bilirubine
- Progestérone
- Phosphore

→ Tube vert : Héparine

- Urée/Créat
- Ionogramme
- Troponine
- Calcémie
- Glycémie
- TAP/TGP : glutamate pyruvate transaminase
- Ferritinémie
- PAL : phosphatase alcaline
- BI
- BD
- Acide urique
- Bilirubine

→ Tube violet : EDTA

- FNS
- HBC
- HCV
- HIV
- TPHA
- Groupage
- Frottis sanguin

→ **Tube bleu : Cirate**

- TP
- VS
- GS
- Fibrinogène
- TCK
- INR

MOTIFS DES CONSULTATIONS

• Abréviations

- QSP : quantité suffisant pour
- Flc : flacon
- Bte : boîte
- Ddp : dose du poids
- Sac : sachet
- Cp : comprimé
- Sus buv : suspicion buvable
- Cà m : cuillère à mesure

I. Vomissement

→ **Enf, Nné, NRS :**

Vomiteb sirop 1 ddp 3*/j → 1 flc

→ **>2ans :**

Domperidone sirop 1 ddp 3*/j → 1 flc

+ **RHD :**

- Adulte : boire bcp l'eau.
- Enf : **SRO** sachet saidal → 1 bte
1 sachet ds 1L d'eau bouillie refroidie
2 càs : 50cc après chaque vms.

II. Douleurs abdominales

- **Spasfon** → 1 bte
Petit enf : Lyoc , 1cp 3*/j
Grand enf : cp 80mg 1cp 3*/j
- **Debridat** → 1 bte
Petit enf : sirop enfant 1 flc, 1 cà m 3*/j
Grand enf : cp 100mg 1 bte, 1cp 3*/j.
- +/- **Bedelix** sachet 1 sachet 3*/j → 1 bte.
- Si douleur de FID → suspicion appendicite :
Avis CCI.

III. Diarrhée

- **Tiorfan** sachet 10mg → 1 bte
1 sachet 3*/j (> 3ans)
½ sachet 3*/j (< 3ans)
- **Smecta** sachet 10mg → 1 bte
½ sachet 3*/j Enf
1 sachet 3*/j Adulte 125 – 200mg
- **Flagyl** sirop 30mg/kg/j 1 cà m 2*/j → QSP 8j
(si glaire + fièvre).
- **SRO** sachet → 1 bte
1 sachet ds 1L d'eau bouillie et refroidie
après chaque selle.
Si < 2ans : 50cc.

IV. Constipation

- **Debridat** sirop 1 ddp 3*/j → 1 flc
→ Si enf > 12 ans :
- **Trimébutine** cp 1cp 2*/j → 1 bte
- **Duphalac** sirop → 1 flc
Forlax sirop < 1an : 1*/j

1 – 6ans : 1cc 2*/j

>6ans : 3*/j

- **Glycérine** suppo 1 -2 suppo/j → 1bte.

V. Brûlé

→ En fonction de profondeur :

- **1^{er} degré** : érythème douloureux, sans phlyctène.

- **2^{ème} degré** :

*Superficielle : phlyctène douloureuse

*profonde : blancheur, phlyctène de grand diamètre.

- **3^{ème} degré** : perte de sens, peau cartonnée.

→ **Agents** : thermiques +++, électriques, chimiques, radioactif...

→ **Conséquences** :

P1 : choc hypovolumique + hémococoncentration =

P2 : réponse inflammatoire systémique.

→ **Signes de gravité** :

- SCB (surface corporelle brûlée) >
12 - 15% → adulte
20% → âgé/enf
10% → NRS

- Age : > 70ans / NRS

- Lésion / tares associées.

→ **SCB (enf +++)**

- Si < 10ans :

Tête : 9 + (10 – âge)

MI : 36 – (10 – âge)

- Tête + cou : 17 %
- Face ant du tronc : 18%
- Face post du tronc : 18%
- Chaque jambe : 14% (*2)
- Chaque bras : 9% (*2)
- Périné : 1%
- Total 100%

Règle de
9 de
Wallace

→ **Ordonnances des soins** :

- **Calcial** sirop 1càm/j → 1flc

- **Ferrostrane** sirop 1càm2*/j → 1flc

- **Atarax** sirop 2mg/ml 1càm/j le soir → 1flc

- **Mebo** pommade (pour la face) 1flc/
Flammazine (pour le reste du corp) (2^{ème} degré superf).

- Tulle gras.

- Si sortie : + **Augmentin**.

→ **Si hospitalisation** : en IVL : SCB > 5%

- **Claforen** pds *100/3 → 3*/j

- **Flagyl** pds *30/3 → 3*/j

- **Perfalgon** pds *15 → 4*/j

- **Solumédrol** 1mg/kg → /j

- RDB 100cc/kg → /24

→ **Schéma de CARVAJAL**

(valable pour enf < 40kg).

J1 : 2000*SC + (5000 * SB).

J2 : 1500*SC + (4000 * SB).

J3 : 2200*SC + (2800 * SB).

$$\text{SC: } \frac{4p+7}{p+90}$$

$$\text{SB: } \frac{\text{Sc*estimation}}{100} = \text{SC} * \text{X\%}$$

SC : surface corporelle totale en m²

P : poids en kg.

SB : surface corporelle brulée en m²

X% : 0.X

→ **Albumine** : poids * 5 = Q

Dilution : 3Q * SG.

→ Pour l'**Augmentin** (à titre externe) :

Si > 40 kg = 50 mg/kg/j * 3/j.

V. Appendicite médicale

→ Si pas d'admission

1) **Oroken** sirop enf $1\text{ddp} \times 2/\text{j}$ → QSP 15j

Si **Claforan** 100mg/kg/j 4*/j

Augmentin 80mg/kg/j

Oroken : 4-8 mg/kg/j

<10kg : sirop 40mg 1ddp *2/j

10-40kg: sirop 100mg 1ddp*2/j

>40kg: cp 200mg 1cp*2/j

2) **Flagyl** sirop enf 125mg $1\text{càm} \times 3/\text{j}$ → QSP 7j

30mg/kg/j en 3 prises.

Si cp : 250 – 500mg

3) **Doliprane** suppo $1\text{suppo}/6\text{h}$ → 1 bte

S'il y a une fièvre / une douleur

< 8kg : 100mg

8-12 kg : 150mg

13-20kg : 200kg

>20kg: 300kg

Cp: 500mg – 1000mg

→ Si hospitalization

- **Claforan** : pds *100/3

- **Flagyl** : pds *30/3

- **Perfalgan** : pds *15

- **RDB** : 100cc /kg

- +/- **Solumédrol** : 1mg/kg

- +/- **Gentamycine** 8mg * inj IM/le soir QSP 6j.

VI. Ingestion pièce monnaie (> 20j)

1) **Gaviscon** sachet $1\text{sachet} \times 2/\text{j}$ après repas → 1 bte

2) **Ultra lévure** sachet $1\text{sachet} \times 1/\text{j}$ → 1 bte

3) **Ezilax** sirop $1\text{càm} \times 2/\text{j}$ → 1 flc

VII. Ingestion caustique (ph <2 ou >12)

Problème majeure : risqué évolutif/sténose des lésions (+++ > 3 semaines).

ASP +++

- Selon Clinique/causticité

- Arrêt l'alimentation orale.

- Surveillance +++ (radiologique) : si normale :

Nobac sirop $1\text{càm} \times 2/\text{j}$ → 1 flc.

VIII. Abscess anal +/- collecté

1) **Augmentin** 80mg/kg/j → QSP 10j

2) **Doliprane** suppo/cp $1/6\text{h}$ → 1 bte (Si fièvre ou douleur)

3) **Fucidine** pommade $1\text{app} \times 3/\text{j}$ → 1 flc

FORMES CLINIQUES

I. Grosse bourse

→ Brutale

- Douleur aigue < 2h < 6h : échographie avec doppler pour éliminer une torsion testiculaire → **trt chirurgical.**
- Progressif : évaluation, si pas d'urgence : échographie, peut être orchi-épididymite → **trt médical.**

II. Appendicite

Douleur abdominale (surtout FID +++), fébrile + sensibilité à la palpation → échographie si appendicite → bilan complet.

III. Invagination

- Age < 2ans.
 - Sd grippal
 - Cris incessants
 - Refus de tété
 - Douleur brutale
- Echographie : image en cocarde

IV. Ingestion pile bouton

Admission : ASP (localisation)

V. Occlusion

- AMG (+3jours) + AEG + vms + distension abdominale → ASP

VI. Ingestion du corps étranger

ASP : localisation :

- Si **œsophagienne** : enlever par la fibroscopie.
- Si **intestinale** : patienter 48-72h : rendez-vous 48-72h si non retirer.

VII. Hernie ombilicale/inguinale

→ Réductibilité :

- Oui : échographie.
- Non : solumédrol 1mg/kg → après 30min : réductible, si non → bloc chirurgical.
- Fille : opérer en urgence, la réductibilité est Cl.
- Garçon : on peut réduire.

LES ORDONNANCES DES URGENCES EN CCI

• Ordonnance pour brûlé

- 1) Clacial sirop 1 cam/j ----- → 1 flc
- 2) Ferrostrane sirop 1 cam * 2/j ----- → 1 flc
- 3) Astrox sirop 1 cam /j le soir ----- → 1 flc
- 4) Mebo pommade / Flammazine : les 2 sont types de Biafine.
- 5) Tulle gras.
- 6) Doliprane + Augmentin : à la sortie.
- 7) Bande vello.

• Hernie inguinale engorgée

- 1) Solumédrol 1 mg/kg IV : Pour faire une réduction.

On injecte solumédrol pour faire une réduction :

- En cas d'une hernie inguinale engorgée chez un **garçon** : après 30 mn, si la hernie reste irréductible donc considérer comme une urgence opératoire.
- En cas d'une hernie inguinale engorgée chez une **filles** : c'est une urgence opératoire, directement transférer au bloc opératoire.

NB : toujours vérifier d'abord que les testicules sont en place !

• Médicaments de CCI

- 1) Claforan (céfotaxim) : 100 mg/kg → résultat/ 3 = X : X * 3/j sans dépasser 3g/j, > 30 kg → 1g * 3/j.
- 2) Augmentin 100 mg/kg → résultat/ 3 = X : X * 3/j.
- 3) Flagyl 30 mg /kg → résultat/ 3 = X : X * 3/j **ou** 10 mg/kg * 3/j.
- 4) RDB : 100 ml/kg /24h sans dépasser 2 l/j.
- 5) Perfalgol : 15 mg/kg : A, A * 4/j.
- 6) Solumédrol 1mg/kg
- 7) Oroken (céphalosporine) sirop 8mg/kg * 2/j.

• Schéma de Carvajal : remplissage chez un brûlé

J1 : 2000*SC + (5000 * SB).

J2 : 1500*SC + (4000 * SB).

J3 : 2200*SC + (2800 * SB).

$$SC : \frac{4p+7}{p+90} \quad SB : \frac{Sc_{\text{estimation}}}{100} = SC * X\%$$

SC : surface corporelle totale en m²

P : poids en kg.

SB : surface corporelle brûlée en m²

X% : 0.X

→ Albumine : poids * 5 = Q

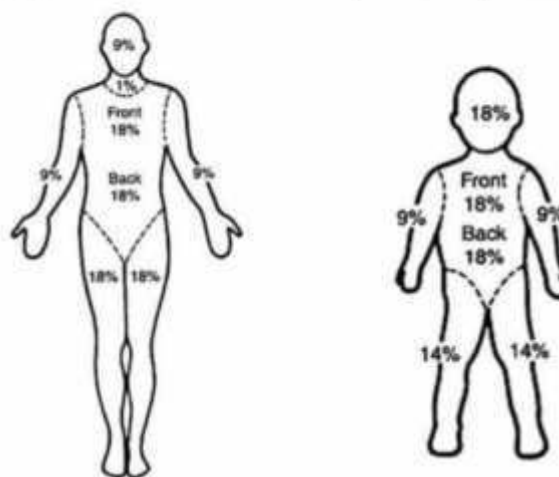
Dilution : 3Q * SG.

→ Pour l'Augmentin (à titre externe) :

si > 40 kg = 50 mg/kg/j * 3/j.

En général, ce schéma calcule par le résident.

Segment corporel	Surface atteinte	
	Adulte	Enfant
Tête et cou	9 %	17 %
Face antérieure du tronc	18 %	18%
Face postérieure du tronc	18 %	18%
Chaque jambe	18 %	14%
Chaque bras	9 %	9%
Périnée	1 %	1%
Total	100 %	100%



• RDB

RDB : SG 10% pendant 24h.

= 100 cc/kg pour le poids < 10kg

+ 50 cc/kg pour le poids entre 10 et 20 kg

+ 20 cc/kg pour le poids > 20kg.

Ex si poids 44kg

= 100*10 + 50*10 + 14*10 = 1640 ml.

RDB = 1640 ml (24 de G 10%).

• Avis CCI

Il s'agit de l'enfant Agé de Victime d'un accident de la circulation ce qui lui a engendré :

Chez qui l'examen clinique retrouve :

→ L'enfant éveillé, conscient, coopérant, EG conservé.

→ BCCM : bonne coloration cutané-méqueuse

→ BCHD : bon constantes hémodynamiques.

→ Thorax de morphologie normale sans point d'impact + ampliation thoracique symétrique.

• ACCIDENT DE LA VOIE PUBLIQUE ou de la circulation.

→ Rx de thorax

→ Rx de bassin

→ Si l'enfant est stable : échographie abdomino-pelvienne.

→ Descriptif si échographie sans anomalies.

• Médicaments (à titre externe)

- 1) Augmentin 50mg/kg/j * 3/j (qsp /j).

- 2) Oroken sirop enfant : 1 ddp*2/j (qsp/j)
 < 10kg : sirop 40mg (1 ddp*2/j).
 10 - 40kg : 100mg (1 ddp*2/j).
 >40kg : cp 200mg * 2/j.
- 3) Flagyl sirop 25mg (qsp 7j).
 100mg/kg/j.
 Si cp : 250 – 500mg.
- 4) Doliprane suppo : 1 bte
 < 8 : 100mg
 < 12 : 150 mg
 < 20 : 200 mg
 >20 : 300 mg
 Cp : 500mg – 1000mg.

Fiche à remplir après la circoncision

06/09/2018

Page 1/2

CHU DE SETIF
SERVICE DE CHIRURGIE PEDIATRIQUE
Pr Z. SOUALLI
FICHE DE LA CIRCONCISION

Identification de l'enfant:
Nom et Prénom : BENKATH SAÏFOUDINE
Age : 03 ans 1
Tél : 0697625058
Adresse : Moucin 2

Examen clinique du prépuce normal :

- * Aspect photo : 
- * Longueur de la verge (la partie depuis l'émergence au développement normal)
- * Épaisseur de la verge en position normale

Examen de la verge en position défective :

- * Aspect du prépuce :
 - Long ☐
 - Moyen ☒
 - Court ☐
- * Vasculature avec transillumination:
 - importante ☒ Rare ☐
- * Mobilité du méat :
 - Oui ☐ Non ☐
 - Rétraction facile (ils entraînent) ☐
 - Application difficile ☐
- * Surface du méat :
 - un ☒ deux ☐ plus ☐
- * Méat à l'apex :
 - Oui ☒ Non ☐
- * Aspect du méat :
 - Long ☐ Court ☒
 - Droite ☐ Gauche ☐
- * Aspect du corps médian :
 - Long ☐ Court ☒
 - Non ☒ Oui ☐
 - d droite ☐
 - d gauche ☐
- * Aspect du tissu adipeux pelvienne par introduction verticalement (indien au niveau du prépuce)
 - < 0.1 cm ☒
 - = 0.1 cm ☐
 - = 1 cm ☐
 - > 2 cm ☐
- * Aspect du scrotum :
 - testicules
 - En place ☒
 - Hypogonadiques ☐
 - Non palpables ☐
 - glandes
 - Symétriques ☒
 - Asymétriques ☐
 - Pas de glandes ☐
 - Pas de glandes ☒
- * Présence de glandes au niveau du prépuce :
 - Oui ☐ Non ☒
- * Vierge couverte en position verticale :
 - Oui ☐ Non ☒
- * Anomalies mélangées :
 - Hypospadias + courbure ☐
 - Hypospadias + courbure + transposition ☐
- * Circuncision bilatérale :
 - Oui ☐ Non ☒

Page 2/2

6

1




2




3




* (prépare bien l'écritural) (prépare l'écritural) (prépare l'écritural)

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430